ANÁLISIS DE EMPRESA COTIZADA

Edwards Lifesciences Corporation

EW · NYSE · ISIN US28176E1082 · Salud

Fecha de corte de los datos: **14 oct 2026** · Divisa: **USD** · Cifras en **millones**

Recomendación **Mantener**	Precio **85,76 USD**	Objetivo 12 m **97,61 USD**	Rentabilidad 12 m **+13,8 % (base +16,0 %)**
Valor intrínseco **57,69 USD · mercado 63,67**	Convicción **Baja**	Capitalización **49.432 M**	EV/EBITDA próx. 12 m **n.d.**
Deuda neta aj. / EBITDA **-1,8x**			

Nombre	**Edwards Lifesciences Corporation**	Ticker / ISIN	**EW / US28176E1082**
Mercado	**NYSE**	Índice de referencia	**S&P 500**
Sector / industria	**Salud / Equipos y suministros médicos**	Sede · fundación	**Irvine (California) · 1958**
		Web	**https://www.edwards.com**
Precio (fecha)	**85,76 (13 oct 2026)**	Rango 52 semanas	**72,30 – 96,29**
Acciones diluidas (M)	**576,4**		
Capitalización	**49.432 M USD**	Valor empresa	**45.778 M USD**
		Próximos resultados	**4 nov 2026**

Contenido

- Síntesis y recomendación (una página)
- Resumen ejecutivo
- Parte I — Negocio y sector: 1. Historia · 2. Modelo de negocio · 3. Sector y mercado · 4. Posición competitiva
- Parte II — Finanzas: 5. Cuenta de resultados · 6. Resultados recientes · 7. Balance y circulante · 8. Flujos de caja · 9. Calidad contable · 10. Rentabilidad · 11. Deuda y solvencia · 12. Asignación de capital
- Parte III — Equipo y gobierno: 13. Equipo directivo · 14. Gobierno corporativo
- Parte IV — Mercado y valoración: 15. Consenso · 16. Bolsa · 17. Múltiplos históricos · 18. Comparables · 19. Transacciones · 20. DCF · 21. Escenarios · 22. Suma de partes · 23. Síntesis
- Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento: 24. Catalizadores · 25. Riesgos y pre-mortem · 26. ESG · 27. Preguntas abiertas · 28. Sentimiento en foros y comentarios
- Anexos: controles de calidad, información no disponible y fuentes
- Las secciones sin información verificable no se imprimen; quedan listadas en el anexo «Información no disponible».

No constituye recomendación de inversión.

Síntesis y recomendación

Mantener · Convicción Baja · Objetivo a 12 meses **97,61 USD** frente a 85,76 · Rentabilidad a 12 meses **+13,8 % (base +16,0 %)** · Valor intrínseco 57,69 USD · con la prima implícita del mercado: 63,67 (-25,8 %) · Alcista / bajista -22,5 % / -46,9 %

La recomendación y por qué. Mantener, con convicción baja. Con nuestro BPA y la regla de múltiplos v3, el objetivo a 12 meses es de 97,61 USD frente a 85,76 USD de cierre del 13 de octubre: +13,8 % ponderado y +16,0 % en el caso base, con una asimetría favorable (2,32x). El objetivo medio de los analistas (101,59 USD) queda dentro de nuestro rango. No es Comprar por dos razones: la ponderada no llega al 15 % y el valor intrínseco del DCF (57,69 USD en la síntesis) está un 33 % por debajo del precio. La convicción es baja porque las cifras de núcleo salen de extractos de búsqueda y no de los documentos completos, y porque el valor intrínseco y el objetivo a 12 meses dan señales opuestas; subiría si el 3T26 (4 de noviembre) eleva la guía y si el precio baja de ≈80 USD.

El negocio. Líder mundial de la válvula aórtica percutánea (TAVR), con más del 55 % del mercado y tres cuartas partes de sus 6.067,6 M USD de ventas de 2025 [3, 17]. Su ROIC contable (15,7 % en 2025, ≈22 % con el beneficio ajustado) supera al WACC del 10,15 % en 5,6 puntos. La sostenibilidad del crecimiento es «Sí»: proyectamos un 9,5 % anual en 2027-28 sin subir precios y con una cuota de TAVR estable, apoyado en la nueva cobertura de Medicare (10-sep-2026), la indicación en asintomáticos y TMTT creciendo un 45-60 % [5, 19, 23].

Finanzas. Las ventas aceleran (+11,5 % en 2025 y ≈15 % en el 1S26) y el BPA ajustado vuelve a crecer a dos dígitos tras un 2025 plano (2,56 USD, +5,3 %; guía de 2026 de 2,95-3,05) [4, 5]. Caja neta de ≈3.650 M a junio de 2026 y caja libre de ≈1.335 M en 2025 [10, 12]. El margen contable lleva cada año cargos (litigios, I+D comprada, JenaValve) que la empresa excluye: el contable de 2025 (1,80 USD por acción) queda lejos del ajustado.

Valoración. El DCF da 58,18 USD y el inverso dice que el precio descuenta un crecimiento del 14,8 % anual en 2027-35, el doble de nuestro 7,1 %, o una rentabilidad del 7,7 % frente a nuestro WACC del 10,15 %. Frente a los comparables (17,5x) Edwards cotiza con una prima del ≈50 % (26,0x), pero frente a su propia historia está barata: 26,5x nuestro BPA de 2027e frente a una mediana de 29,1x en cinco años. La regla a 12 meses recoge esto último (base 27,7x × 3,59 USD de BPA de 2028e); el DCF, lo primero. Nuestra tesis es la de 12 meses, pero la diferencia con el DCF es de tasa de descuento: si el mercado exigiera el 10 %, la acción valdría ≈58 USD.

Riesgos y catalizadores. El mayor riesgo es perder cuota en los hospitales nuevos que abre la cobertura de Medicare (bajista −17,7 % a 12 meses). Catalizadores con fecha: PROGRESS en TCT (3-nov), resultados del 3T26 (4-nov) y guía de 2027 en diciembre. El sentimiento de los foros es dividido y no contradice a la tesis; algunos leen la cobertura de asintomáticos como inmediata cuando aún faltan estudios aprobados [19, 46].

Qué cambiaría la decisión. Comprar por debajo de 57,69 USD (donde se cumplen ponderada, base y valor intrínseco) o, con confirmación de las cifras en el 10-Q y una guía de 2027 de ventas ≥ 10 %, revisar el DCF; Vender por encima de 108,46 USD. Bajaríamos el base si TAVR crece menos del 6 % a divisa constante dos trimestres seguidos.

Resumen ejecutivo

Confianza: Baja

Recomendación: Mantener · Convicción: Baja · Horizonte: 12 meses · Objetivo a 12 meses: **97,61 USD** (rentabilidad +13,8 % (base +16,0 %)) · Valor intrínseco: 57,69 USD (-32,7 % sobre 85,76) · con la prima implícita del mercado: 63,67 (-25,8 %)

Edwards es el líder de la sustitución percutánea de la válvula aórtica, con más del 55 % del mercado mundial, un margen bruto ajustado del ≈78 % y caja neta de ≈3.650 M USD [3, 12, 17]. Tras vender Critical Care en 2024 es una empresa pura de corazón estructural que crece a dos dígitos: +11,5 % en 2025 y ≈15 % en el 1S26 [4, 5, 6].

El precio (85,76 USD) descuenta, según el DCF inverso, un crecimiento del 14,8 % anual durante nueve años, o una rentabilidad del 7,7 %: exigente frente a nuestro WACC. Pero el PER adelantado (26,5x) está por debajo de la mediana de cinco años de la propia Edwards (29,1x), por primera vez desde 2019.

Para invertir hay que creer que la nueva cobertura de Medicare y la indicación en asintomáticos mantienen a TAVR creciendo al 7-8 % y que TMTT llega a rentabilidad; entonces el BPA crece un 11-12 % anual y el múltiplo vuelve hacia su historia. El riesgo es que la competencia se lleve los hospitales nuevos [19, 24].

La decisión

Elemento de la decisión	Valor
Objetivo a 12 meses (nuestro PER × nuestro BPA 2028e, ponderado 25/50/25)	97,61 USD
Bajista / base / alcista a 12 meses	22,2x × 3,18 = 70,60 · 27,7x × 3,59 = 99,44 · 31,5x × 3,84 = 120,96
Rentabilidad a 12 meses: ponderada / del base (con dividendo)	13,8 % / 16,0 %
Regla de múltiplos aplicada	v3: base a mitad de camino hacia la mediana adelantada, sin alejarse del actual más de ×1,1; bajista mín. 5 a (adelantado) o base × 0,80; alcista techo base × 1,35
Objetivo medio de los analistas (solo contraste)	101,59 (nuestro base -2,1 %)
Valor intrínseco (síntesis ponderada, largo plazo)	57,69 USD
Potencial sobre el precio actual	-32,7 %
Rentabilidad por dividendo ordinario	0,0 %
Rentabilidad total esperada a 12 meses	-32,7 %
Escenario alcista / bajista	-22,5 % / -46,9 %
Asimetría (ganancia alcista / pérdida bajista)	-0,48x
Rentabilidad anual implícita en el precio frente al WACC y al que pide el mercado	7,7 % frente a 10,2 % y 9,4 %
Valor objetivo con la prima implícita del mercado (4,2 %, WACC 9,4 %)	63,67 USD
Rentabilidad total esperada con la prima del mercado	-25,8 %
Asimetría con la prima del mercado	-0,32x
Regla absoluta (frente a su coste de capital)	Vender
Regla relativa (frente a lo que pide el mercado)	Vender
Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2035e) frente al previsto para su mercado	14,8 % frente a 9,9 %
¿La calidad de la empresa sostiene el crecimiento previsto?	Sí (7,6 % anual proyectado; sin inversión neta)
Señal del valor intrínseco (regla del DCF, referencia)	Vender
Recomendación según la regla a 12 meses (Comprar: ponderada ≥ 15 %, base ≥ 12 % y valor intrínseco ≥ precio; Vender: ponderada ≤ -10 %)	Mantener

Elemento de la decisión	Valor
Convicción según los criterios (Mantener con las dos reglas de acuerdo y lejos de los umbrales)	Media

Regla (método v2): la recomendación sigue al objetivo a 12 meses, que es nuestro PER × nuestro BPA del ejercicio que mirará el mercado dentro de un año, con la misma regla de múltiplos para todas las empresas (base: el menor entre el PER actual y la mediana de 5 años; bajista: el mínimo de 5 años, o el base −15 % si ya cotiza por debajo; alcista: la media histórica o la de los comparables, sin pasar de base +30 %), ponderado con las probabilidades de los escenarios. Comprar si la rentabilidad ponderada es ≥ 15 %, la del base ≥ 12 % y el valor intrínseco no queda por debajo del precio; Vender si la ponderada es ≤ −10 %; Mantener en el resto. El consenso de analistas solo se compara. El valor intrínseco (DCF) es la referencia a largo plazo; su regla, la de siempre: Comprar si la rentabilidad total esperada a 12 meses es ≥ 15 % y el alcista gana al menos lo que pierde el bajista; Vender si es ≤ −10 %, o negativa con asimetría < 0,5; Mantener en el resto. Se aplica dos veces: con el WACC del análisis (regla absoluta: ¿rinde más que su coste de capital?) y con el WACC que resulta de la prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa: ¿rinde más que lo que hoy pide el mercado, ajustado por su beta?). Manda la relativa, salvo que las dos se contradigan (una Comprar y otra Vender): entonces, Mantener.

Acción	A qué precio
Comprar	Por debajo de 57,69 (ponderada a 12 meses ≥ 15 %, base ≥ 12 % y precio ≤ valor intrínseco)
Mantener	Entre 57,69 y 108,46
Vender o reducir	Por encima de 108,46 (ponderada a 12 meses ≤ -10 %)

Qué cambiaría la recomendación

- Precio por debajo de 57,69 USD: Comprar (pasa las tres pruebas).
- Precio por encima de 108,46 USD: Vender o reducir.
- Crecimiento de TAVR a divisa constante por debajo del 6 % dos trimestres seguidos: rebajaríamos el base y probablemente a Vender.
- Guía de ventas de 2027 ≥ 11 % y margen operativo ajustado al alza en diciembre: subiríamos el base y la convicción.

Dónde discrepamos del mercado

Lo que descuenta el precio.

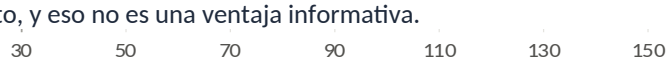
Un crecimiento de dos dígitos durante casi una década (DCF inverso: 14,8 % anual) con una rentabilidad exigida del 7,7 %, por la calidad del negocio y la opción de nuevas indicaciones (asintomáticos, estenosis moderada).

Lo que creemos nosotros.

El crecimiento financiable es menor (9,5 % hasta 2028 y bajando), así que a nuestra tasa la acción está cara; pero a 12 meses el BPA crece un 11-12 % y el múltiplo está por debajo de su historia, lo que da un +13,8 % ponderado.

Por qué podemos tener razón.

No tenemos una visión distinta del mercado sobre el negocio: coincidimos con el consenso en el BPA (−4 %) y en el objetivo (−2 %). Discrepamos en la tasa de descuento, y eso no es una ventaja informativa.



Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	58,18	-32,2 %	50 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	57,56	-32,9 %	10 %
Transacciones precedentes (no se usa)	105,94	+23,5 %	0 %
Escenarios ponderados	57,10	-33,4 %	40 %

A favor

- **Liderazgo en TAVR**: más del 55 % del mercado y salida de Boston Scientific en 2025 [17, 24].
- **Aceleración**: ventas +15 % en el 1S26 y guía elevada tres veces en 2026 [5, 6].
- **Catalizadores con fecha**: cobertura de Medicare (10-sep), PROGRESS (3-nov) y 3T26 (4-nov) [19].
- **Balance**: caja neta de ≈3.650 M, el 7 % de la capitalización [12].
- **Múltiplo bajo su historia**: 26,5x frente a 29,1x de mediana en cinco años.

En contra

- **Valor intrínseco por debajo del precio**: DCF de 58,18 USD (−32 %).
- **Prima frente a comparables**: 26,0x frente a 17,5x de mediana [36].
- **Cargos recurrentes**: el BPA contable (1,80 USD en 2025) queda lejos del ajustado (2,56) [4].
- **Concentración**: TAVR es el 74 % de las ventas y la FTC cierra la vía de compras [16].
- **Datos de núcleo de baja confianza**: cifras de extractos de búsqueda, sin el 10-K abierto.

Qué tiene que pasar para que la tesis funcione

La tesis depende de que TAVR siga creciendo al 7-8 % a divisa constante con la nueva cobertura de Medicare. La señal de que no se cumple: crecimiento de TAVR por debajo del 6 % dos trimestres seguidos o una guía de ventas de 2027 por debajo del 9 % en la conferencia de diciembre.

Indicadores de seguimiento

Indicador	Nivel actual	Umbral de alerta	Por qué importa
Crecimiento de TAVR a divisa constante	+10,5 % (2T26)	< 6 %	Motor del 74 % de las ventas.
Ventas de TMTT (trimestre)	195,9 M (2T26, +44,8 %)	Crecimiento < 25 %	Segundo motor y palanca del margen.
BPA ajustado (guía 2026)	2,95-3,05 USD	Recorte de la guía	Base del objetivo a 12 meses.
PER adelantado	26,5x	< 22x o > 32x	La regla de múltiplos supone que vuelve hacia 29x.

Datos clave

EV/EBITDA últimos 12 m / próx. 12 m	**22,9x / n.d.**	PER últimos 12 m / próx. 12 m	**47,6x / 26,0x**
EV/EBIT últimos 12 m	**25,0x**		
EV/Ventas últimos 12 m	**7,03x**	Rentabilidad por FCF	**2,7 %**
Rentabilidad por dividendo	**0,0 %**	Crecimiento anual de ingresos (2023-2025)	**10,0 %**
Margen EBITDA últimos 12 m	**30,7 %**	ROIC último ejercicio	**15,7 %**
WACC	**10,2 %**	Deuda neta / EBITDA (contable · ajustada)	**-1,8x · -1,8x**
Gobierno (criterios cumplidos)	**7 de 13 (5 sin dato)**		

Parte I — Negocio y sector

1. Historia e hitos

Confianza: Media

Edwards nace en 1958 de la colaboración entre el ingeniero Miles «Lowell» Edwards y el cirujano Albert Starr, que crearon la primera válvula cardiaca artificial de éxito comercial. Fue parte de Baxter hasta su escisión y salida a bolsa en el año 2000. Con Mike Mussallem (primer ejecutivo 2000-2023) apostó por la válvula aórtica percutánea (SAPIEN, aprobada en EE. UU. en 2011), que hoy es tres cuartas partes de las ventas. En 2023 tomó el relevo Bernard Zovighian y en 2024 vendió Critical Care a Becton Dickinson para quedarse solo con el corazón estructural [17, 18].

Año	Hito
1958	Fundación; primera válvula mitral Starr-Edwards (1960).
2000	Escisión de Baxter y salida a bolsa en NYSE.
2011	Aprobación de SAPIEN en EE. UU. para pacientes inoperables.
2019	SAPIEN 3 aprobada en pacientes de bajo riesgo quirúrgico: TAVR pasa a ser la opción general.
2024	Venta de Critical Care a Becton Dickinson por ≈4.200 M USD; empresa pura de corazón estructural [18].
2026	La FTC bloquea la compra de JenaValve (enero); la FDA aprueba SAPIEN 3 en estenosis aórtica grave asintomática y CMS amplía la cobertura de Medicare (10-sep) [19, 20, 23].

2. Modelo de negocio

Confianza: Media

Edwards Lifesciences diseña y fabrica válvulas cardiacas y sistemas de reparación para enfermedades estructurales del corazón. Tres líneas: TAVR (sustitución percutánea de la válvula aórtica, familia SAPIEN), TMTT (terapias percutáneas mitral y tricúspide: PASCAL, EVOQUE, SAPIEN M3) y Surgical (válvulas quirúrgicas). Vende a hospitales y centros de cardiología intervencionista de EE. UU., Europa, Japón y el resto del mundo. Desde la venta de Critical Care a Becton Dickinson (sep-2024, ≈4.200 M USD) es una empresa pura de corazón estructural [1, 2, 3].

Cómo gana dinero

Cobra por válvula implantada: cada procedimiento consume un dispositivo de un solo uso, con precios medios estables en el mundo según la dirección [5]. TAVR pesa ≈74 % de las ventas de 2025 (≈4.500 M USD), TMTT ≈9 % (≈545 M, estimación por la guía 2026) y Surgical ≈17 % [3, 4]. El margen bruto ajustado ronda el 78 % y la empresa gasta ≈17 % de las ventas en I+D (268 M en el 4T25) y ≈38 % en gastos comerciales y generales [3]. El crecimiento depende del número de pacientes tratados (indicaciones nuevas, cobertura de Medicare, capacidad de los hospitales), no del precio. TMTT aún pierde dinero o apenas gana: su escala es la palanca del margen a medio plazo.

Segmentos (2025)

Segmento	Ingresos	% del total
TAVR	4.500	74,2 %
TMTT	545	9,0 %
Surgical	1.023	16,9 %



Ingresos por segmento	2025
TAVR	4.500
TMTT	545
Surgical	1.023

Clientes, recurrencia y poder de precios

Clientes hospitalarios muy repartidos; la demanda la decide el equipo cardiaco (cardiólogo y cirujano) y el reembolso público (Medicare en EE. UU.). El poder de precios es de mantenimiento: la dirección dice que el precio medio de TAVR fue estable en el 2T26 pese a la entrada de competidores [5]. La salida de un competidor de TAVR en el 2T25 ayudó al volumen de 2025-26 [5].

Indicadores operativos

Indicador	Anterior	Actual	Variación	Lectura
Ventas TAVR (trimestre)	≈1.130 M (2T25)	1.260 M (2T26)	+11,3 % (+10,5 % a divisa constante)	Guía 2026 de TAVR: 4.750-5.000 M, +8-9 % a divisa constante [5].
Ventas TMTT (trimestre)	≈135 M (2T25)	195,9 M (2T26)	+44,8 %	Guía 2026 elevada a 760-780 M [5].
BPA ajustado (año)	2,43 USD (2024)	2,56 USD (2025)	+5,3 %	Guía 2026: 2,95-3,05 USD (+17 % en el punto medio) [4, 5, 7].

3. Sector y mercado

Confianza: Baja

El mercado relevante es el de la sustitución percutánea de la válvula aórtica (TAVR/TAVI), que supone el 74 % de las ventas de Edwards, más el mercado naciente de la reparación y sustitución percutánea mitral y tricúspide (TMTT) y el de válvulas quirúrgicas, maduro. Usamos el tamaño mundial de TAVR de las firmas de estudios de mercado, que divergen: GMI da una cuota de Edwards superior al 55 % en 2025 y otra fuente prevé ≈10.000 M USD en 2029 con un crecimiento del 9,9 % anual [17, 18]. Con las ventas de TAVR de Edwards (≈4.500 M en 2025) y una cuota del 55-60 %, el mercado ronda los 7.500-8.000 M USD.

Tamaño del mercado	**≈7.500-8.000 M USD en 2025 (estimación propia a partir de la cuota de Edwards de más del 55 % [17] y de sus ventas de TAVR); ≈10.000 M en 2029 según otra fuente [18].**	Posición en el ciclo	**Expansión**
		Crecimiento previsto anual	**9,9 %**
Cuota de los 5 primeros	**80 %**	Estructura	**Concentrada**

Motores de la demanda

Motor	Efecto	Horizonte	Evidencia
Envejecimiento y estenosis aórtica infratratada	+	Estructural	La mayoría de los pacientes con estenosis grave no se trata; el ensayo PROGRESS (estenosis moderada) tenía una edad media de 78 años [22].
Indicaciones y cobertura nuevas (asintomáticos)	+	Estructural	FDA aprueba SAPIEN 3 en estenosis grave asintomática (EARLY TAVR) y CMS finaliza el 10-sep-2026 la nueva cobertura: quita el registro obligatorio para los sintomáticos y cubre a los asintomáticos con evidencia en desarrollo [19, 20, 23].
Capacidad de los hospitales	+/−	Cíclico	La nueva cobertura elimina los requisitos de volumen de hospital y operador, lo que permite abrir más centros [19].
Competencia y precio	−	Estructural	Medtronic (Evolut) y Abbott (Navitor) compiten; Boston Scientific salió de TAVR en 2025; precio medio estable [21, 24].

Las cinco fuerzas

Amenaza de entrada Poder de los proveedores

Fuerza	Intensidad (1-5)	Justificación
Rivalidad	2	Duopolio de hecho en EE. UU. (Edwards y Medtronic), con Abbott como tercero; Boston salió en 2025 [21, 24].
Poder de los clientes	3	Hospitales y Medicare fijan el reembolso; precios medios estables pero sin subidas.
Poder de los proveedores	1	Tejido pericárdico bovino y metales; fabricación propia.
Amenaza de entrada	2	Ensayos de miles de pacientes y años de datos de durabilidad; la FTC además bloquea la concentración [16].
Amenaza de sustitutos	2	La cirugía abierta pierde peso frente a TAVR; no hay fármaco que frene la estenosis.

Ciclo

El volumen de TAVR depende de la demografía y de la cobertura, no del ciclo económico: en 2020 cayó por el aplazamiento de cirugías y se recuperó en 2021. En 2023-24 se frenó por la capacidad de los hospitales y la competencia; en 2025-26 acelera de nuevo (+8,6 % a divisa constante en 2025 y +10,5 % en el 2T26).

Regulación

La decisión nacional de cobertura de Medicare (NCD) finalizada el 10-sep-2026 quita la cobertura con evidencia en desarrollo (CED) a los pacientes sintomáticos, elimina los requisitos de volumen de los hospitales y cubre a los asintomáticos solo dentro de estudios CED aprobados, que aún no existen según el Colegio Americano de Cardiología [19, 20]. La FTC vigila la concentración en válvulas cardiacas (JenaValve) [16].

Tendencias y disrupción

Tratar antes: pacientes asintomáticos (EARLY TAVR) y estenosis moderada (PROGRESS, resultados en TCT el 3-nov-2026) [22, 23]. Mitral y tricúspide percutáneas (EVOQUE, PASCAL, SAPIEN M3) con crecimiento del 45-60 %. Edwards gana con las dos: lidera en evidencia clínica.

4. Posición competitiva y foso

Confianza: Media

Cuota de mercado	**55,0 %**	Posición	**1.° mundial en TAVR (más del 55 % del mercado en 2025, según GMI) [17]; líder en tricúspide percutánea (EVOQUE) y en válvulas quirúrgicas.**
Foso	**Amplio**	Tendencia del foso	**Estable**

Competidor	País	Cotiza	Cómo compite
Medtronic (Evolut)	Irlanda	MDT	Segundo en TAVR con válvula autoexpandible; competidor directo en EE. UU.
Abbott (Navitor)	EE. UU.	ABT	Tercero en TAVR y líder en reparación mitral (MitraClip), rival de PASCAL [24].
Boston Scientific	EE. UU.	BSX	Salió de TAVR en 2025 (ACURATE): la salida ayudó al volumen de Edwards [24].
Meril Life Sciences	India	–	Válvulas de bajo coste en India y mercados emergentes [17].



Fuentes de ventaja competitiva



Fuente	Puntuación (0-5)	Evidencia
Efectos de red	1	Formación de equipos cardiacos y datos de registro: efecto débil.
Costes de cambio	3	Los equipos cardiacos se forman en un sistema (balón expandible) y cambian poco.
Intangibles (marca, patentes, licencias)	5	Evidencia clínica de 10 años de durabilidad de SAPIEN y ensayos que abren indicaciones (EARLY TAVR, PROGRESS); litigios de patentes ganados [6, 7].
Ventaja en costes	2	Margen bruto ajustado ≈78 %, pero sin ventaja de costes clara frente a Medtronic.
Escala eficiente	4	Duopolio de hecho; un tercer entrante (Boston) se retiró tras años de pérdidas [8].

Amenazas

La amenaza principal es que Medtronic o Abbott ganen cuota con datos clínicos mejores en anillos pequeños o con precio en los centros nuevos que abre la cobertura de Medicare. Probabilidad media a cinco años. La regulación antimonopolio cierra a Edwards la vía de comprar tecnologías adyacentes (JenaValve) [16].

Parte II — Finanzas

5. Cuenta de resultados

Confianza: Baja

Periodo	Ingresos	Crec.	M. bruto	EBITDA	M. EBITDA	EBIT	M. EBIT	B. neto	BPA	DPA	Tipo imp.
2023	5.010	–	80,5 %	1.439	28,7 %	1.309	26,1 %	1.220	2,00	0,00	11 %
2024	5.440	+8,6 %	79,5 %	1.520	27,9 %	1.379	25,3 %	1.396	2,33	0,00	10 %
2025	6.068	+11,5 %	–	1.422	23,4 %	1.264	20,8 %	1.056	1,80	0,00	17 %

Crecimiento anual compuesto 2023-2025: ingresos **10,0 %**, EBITDA **-0,6 %**, BPA **-5,1 %**.



Ventas de operaciones continuadas de 5.010 M en 2023, 5.439,5 M en 2024 (+8,6 %) y 6.067,6 M en 2025 (+11,5 %; +10,7 % a divisa constante), todo orgánico [2, 3, 4, 7]. TAVR crece un 8,6 % a divisa constante en 2025 y TMTT más de un 40 % [3]. El margen operativo contable cae del 26,1 % en 2023 al 20,8 % en 2025 por cargos que la empresa excluye de su cifra ajustada (litigios, I+D en curso comprada, valor de participaciones, JenaValve) [1, 16]; en ajustado, el BPA pasa de 2,43 USD a 2,56 (+5,3 %), por debajo de las ventas por más gasto comercial y de I+D [4, 7]. En el 1S26 las ventas crecen ≈15 % y el BPA ajustado es de 0,78 USD en cada trimestre (frente a 0,64-0,67 en 2025) [5, 6].

Ajustes y partidas no recurrentes

Usamos cifras contables de operaciones continuadas en la cuenta y el BPA ajustado de la empresa para el objetivo a 12 meses y el PER histórico (2,43 USD en 2024 y 2,56 en 2025) [4, 7]. La diferencia entre los dos (≈0,75 USD por acción en 2025) son cargos de litigios, amortización de intangibles comprados, I+D en curso adquirida y ajustes de valor de participaciones; se repiten casi todos los años, así que no son del todo extraordinarios. Las amortizaciones de 2023-2025 son estimación propia (≈2,6 % de las ventas, con 166 M en los 12 meses a jun-26 según MarketScreener). El BPA continuado y las acciones diluidas se derivan del beneficio y del BPA total publicados (2,30, 6,97 y 1,83 USD) [13].

6. Resultados recientes

Confianza: Media

Periodo	Ingresos	Crec. interanual	Crec. orgánico	BPA	Frente al consenso
4T24	1.390	+9,0 %	–	0,59	Superior
1T25	1.414	–	–	–	–
2T25	1.532	–	–	–	–
3T25	1.552	–	–	–	–
4T25	1.570	+13,3 %	+11,6 %	0,58	Inferior
1T26	1.650	+16,7 %	+12,7 %	0,78	Superior
2T26	1.740	+13,6 %	+12,5 %	0,78	Superior

Lo que dijo la dirección en las últimas presentaciones

En el 2T26 (23-jul) la dirección subió la guía de ventas a divisa constante al 10-11 % (antes 9-11 %), la de TAVR al 8-9 % (4.750-5.000 M) y la de TMTT a 760-780 M, y mantuvo el BPA ajustado en 2,95-3,05 USD pese a un tipo impositivo más alto (16-19 %) por el cambio del crédito fiscal de I+D de California [5, 14]. Atribuyó parte del crecimiento de TAVR a la salida de un competidor en el 2T25 y a los datos de durabilidad a largo plazo de SAPIEN, y dijo que los precios medios siguen estables [5]. Frente al 1T26 (23-abr), cuando ya subió la guía tras un trimestre del +16,7 %, el discurso pasó de «aceleración» a «cobertura y capacidad»: las preguntas de los analistas se centraron en el calendario de la nueva cobertura de Medicare (decisión final el 10-sep), en cuánto volumen añade en 2027 y en si el margen de TMTT mejora [6, 14]. La dirección no dio cifras de 2027. El 4T25 había fallado en BPA (0,58 frente a 0,62 de consenso) por gasto en I+D y comercial [4]. Ventas de 1T-3T25 calculadas por diferencia con el crecimiento publicado (estimación propia).

7. Balance y capital circulante

Periodo	Activo total	Fondo com. + intang.	Circulante	Caja	Deuda fin.	Arrend.	Deuda neta	Patrimonio	DN/ EBITDA
2023	9.363	0	0	1.633	597	0	-1.036	6.719	-0,7x
2024	13.055	0	0	3.976	598	0	-3.378	9.998	-2,2x
2025	13.697	0	1.786	4.226	598	0	-3.628	10.338	-2,5x

Periodo	Circulante / ventas	Días de cobro
2023	0,0 %	–
2024	0,0 %	–
2025	29,4 %	40

Días de inventario y de pago calculados sobre el coste de ventas.

Cambio de perímetro (2024: Venta de Critical Care a Becton Dickinson (cerrada el 3-sep-2024, ≈4.200 M USD): la cuenta se presenta como operaciones continuadas desde 2022; el balance de 2023 todavía la incluye.). Los ratios de balance de ese año (días, circulante, deuda neta / EBITDA, ROIC) y los indicadores de calidad contable no son comparables con los anteriores.



Balance con caja neta de ≈3.650 M a junio de 2026 (≈6,3 USD por acción) tras cobrar los ≈4.200 M de Critical Care en 2024 y recomprar ≈885 M de acciones en 2025 (11,7 M de acciones, 750 M en recompra acelerada) [1, 12]. El circulante pesa: existencias de 1.126 M y clientes de 660 M a cierre de 2025, ≈29 % de las ventas, propio de un fabricante de dispositivos con inventario en consigna en los hospitales [8]. Los balances de 2023 y 2024 vienen del 10-K 2024 y del informe anual; el de 2025, de un agregador (Capital IQ vía Fintel) salvo caja, clientes y existencias [8, 9, 15].

8. Flujos de caja

Confianza: Baja

Periodo	Flujo operativo	Capex	Arrend.	FCF	B. neto	FCF / B. neto	Capex / ventas	Capex / amort.	FCF por acción
2023	896	253	0	643	1.220	53 %	5,0 %	1,9x	1,05
2024	542	252	0	290	1.396	21 %	4,6 %	1,8x	0,48
2025	1.595	260	0	1.335	1.056	126 %	4,3 %	1,6x	2,28



Acumulado 2023-2025: FCF **2.268**, conversión **62 %** del beneficio neto; adquisiciones 0, dividendos 0, recompras 885.

El flujo operativo de 2024 (542 M) está deprimido por los impuestos de la plusvalía de Critical Care, que se cobró en desinversiones (≈4.200 M, cifra de la operación) [10, 11]. 2025 es el primer año limpio: 1.595 M de flujo operativo y 260 M de capex dejan ≈1.335 M de caja libre, el 22 % de las ventas y ≈126 % del beneficio contable continuado (1.056 M) [10, 11]. El capex (4,3 % de las ventas) es sobre todo de capacidad de fabricación de válvulas (Irvine, Singapur, Costa Rica, Irlanda): estimamos que la mitad es de mantenimiento (≈amortizaciones). La empresa no paga dividendo; las recompras absorben la caja (884,7 M en 2025 y autorización pendiente de 2.000 M) [1]. Las recompras de 2023-2024 no aparecieron en la búsqueda (hueco).

9. Calidad contable

Confianza: Baja

Auditor	**PricewaterhouseCoopers LLP**		
Opinión del último informe	**Favorable**	Ejercicio analizado	**2025**

Indicador	Valor	Lectura
Altman Z	9,58	Zona segura (> 2,99 seguro; < 1,81 riesgo). No aplica a bancos ni aseguradoras, y subestima la solvencia de empresas con grandes anticipos de clientes o prefinanciación pública (contratistas, construcción), que inflan el pasivo.
Piotroski F	6 / 7	Intermedio (4-6).
Flujo operativo / beneficio neto (acumulado)	0,83x	El beneficio se cobra solo en parte: mirar circulante y ajustes.

Criterio Piotroski	Cumple
Beneficio neto positivo	Sí
Flujo operativo positivo	Sí
ROA mejora	No
Flujo operativo > beneficio neto	Sí
Baja el endeudamiento (deuda / activo)	Sí
Mejora la liquidez corriente	n.d.
No emite acciones	Sí
Mejora el margen bruto	n.d.
Mejora la rotación del activo	Sí

Ajustes, criterios contables y remuneración en acciones

Las cifras ajustadas de la empresa excluyen cada año cargos que se repiten (litigios de patentes, I+D en curso adquirida, cambios de valor de contraprestaciones contingentes y de participaciones en start-ups): en 2025 la distancia entre BPA ajustado (2,56) y contable continuado (≈1,80) fue de ≈0,75 USD [4, 13]. Tratamos parte de esos cargos como recurrentes: por eso el margen EBITDA del DCF queda por debajo del margen operativo ajustado más amortizaciones. La remuneración en acciones (168 M en los 12 meses a jun-26, ≈2,6 % de las ventas) se trata como gasto. El I+D se lleva a gastos (no se capitaliza), lo que deprime el ROIC contable frente al económico. Los indicadores del motor (Altman, Piotroski, Beneish) salen incompletos porque faltan partidas del balance (circulante, reservas); no se interpretan. El auditor (PwC) es nombre de memoria del analista, sin proxy abierto: a confirmar.

Señales de alerta

Señal	Nivel	Explicación
Ajustes recurrentes al BPA	Media	Cargos de litigios e I+D comprada casi todos los años; el ajustado sobrestima el beneficio recurrente en ≈5-10 %.
Flujo operativo 2024 distorsionado por la venta de Critical Care	Baja	Impuestos de la plusvalía en el flujo operativo y el cobro en inversión: no comparar 2024 con otros años.

10. Rentabilidad sobre el capital

Confianza: Baja

Periodo	ROIC	ROE	ROA	Margen neto	Rotación del activo	Apalancamiento	Capital invertido
2023	20,5 %	18,2 %	13,0 %	24,4 %	0,54x	1,39x	5.684
2024	20,1 %	16,7 %	12,5 %	25,7 %	0,49x	1,34x	6.184
2025	15,7 %	10,4 %	7,9 %	17,4 %	0,45x	1,32x	6.697

ROIC incremental (variación del NOPAT sobre variación del capital invertido en el periodo): -11,4 % · **WACC**: 10,2 %.

El ROIC (NOPAT contable sobre capital invertido sin la caja) fue del 20,5 % en 2023, del 20,1 % en 2024 y del 15,7 % en 2025, por encima del WACC del 10,15 % en 5,6 puntos en el último año. La caída de 2025 es contable: cargos de litigios y de JenaValve que la empresa excluye de su cifra ajustada; con el beneficio ajustado el ROIC ronda el 22 %. El ROIC incremental de 2025 sale negativo y no se interpreta: el capital invertido cambió con la venta de Critical Care. El I+D (≈17 % de las ventas) va a gastos, lo que infravalora el capital y sobrevalora el ROIC frente a una empresa que lo capitaliza. Frente a los comparables (mediana de ROIC del 16,9 %), Edwards está en la media con el beneficio contable y por encima con el ajustado [36].

11. Deuda y solvencia

Confianza: Baja

Deuda neta a 30 jun 2026	**-3.654 M**	Deuda neta / EBITDA últimos 12 m	**-1,8x**
Deuda neta ajustada / EBITDA	**-1,8x**	Liquidez disponible	**Caja y equivalentes de 2.907 M e inversiones a corto plazo de 1.346 M a 30-jun-2026 (4.253 M), frente a 598,7 M de deuda a largo plazo [12].**
		Coste medio de la deuda	**4,3 %**
Vida media de la deuda	**1,7 años**		



Covenants, pasivos fuera de la deuda y contingencias

La deuda es un único bono de ≈600 M al 4,3 % con vencimiento en 2028 (cupón y vencimiento de memoria del analista, sin documento abierto: dato a confirmar en la nota de deuda del 10-K) [1]. Los pasivos relevantes son

contingencias: litigios de patentes (la empresa registra cargos casi cada año), y la ruptura del acuerdo de JenaValve tras la orden judicial que pidió la FTC (enero de 2026) [16]. No hay pensiones relevantes.

12. Asignación de capital

Confianza: Media

Sin dividendo. Prioridades declaradas: inversión en I+D (≈17 % de las ventas), compras pequeñas de tecnología estructural cardiaca y recompras. En 2025 recompró 11,7 M de acciones por 884,7 M (750 M en recompra acelerada) y le quedan 2.000 M de autorización [1]. La venta de Critical Care (≈4.200 M, 2024) financió la estrategia de empresa pura de corazón estructural [2].

Periodo	FCF	Adquisiciones	Dividendos	Recompras	Ampliaciones	Retorno / B. neto	Acciones (M)
2023	643	0	0	–	0	0 %	609,7
2024	290	0	0	–	0	0 %	598,9
2025	1.335	0	0	885	0	84 %	586,6



Historial de adquisiciones

Año	Objetivo	Importe	Financiación	Resultado
2024	JenaValve (acuerdo de compra; válvula aórtica para insuficiencia)	–	Caja	Bloqueada: la FTC demandó en agosto de 2025 y el juez concedió la medida cautelar en enero de 2026; Edwards renunció a la compra [16].
2024	Venta de Critical Care a Becton Dickinson	4.200	Desinversión (cobro en caja)	Cerrada el 3-sep-2024; la caja financió recompras y deja ≈3.650 M de caja neta [2, 12].

Asignación de capital prudente pero poco eficiente: la caja neta (≈7 % de la capitalización) rinde menos que el negocio, y las recompras de 2025 se hicieron a precios de 70-85 USD, por debajo de nuestro valor a 12 meses. La compra de JenaValve, que habría dado a Edwards la primera válvula percutánea aprobada para insuficiencia aórtica, la bloqueó la FTC por concentración [16]: la vía de crecer comprando dentro de TAVR está cerrada, y queda la orgánica (TMTT, indicaciones nuevas).

Parte III — Equipo y gobierno

13. Equipo directivo

Confianza: Baja

Nombre	Cargo	Desde	Trayectoria y resultados
Bernard Zovighian	Consejero delegado	2023	Dirigió antes el negocio de TMTT de Edwards, que pasó de casi nada a más de 500 M USD de ventas. Desde que es primer ejecutivo ha vendido Critical Care, acelerado TMTT y llevado el crecimiento de las ventas del 8,6 % (2024) al 11,5 % (2025) [26].
Scott Ullem	Director financiero	2014	Director financiero desde 2014; un directorio de directivos menciona una transición prevista en 2026, sin sucesor confirmado en las fuentes leídas [26].

¿Cumple lo que promete?

Año	Lo que prometió	Lo que logró	Cumplió
2024	BPA ajustado de operaciones continuadas guiado en el rango alto tras la venta de Critical Care	BPA ajustado 2,43 USD; ventas +8,6 %	Sí
2025	Ventas TAVR 4.300-4.500 M (guía de mitad de año); TMTT 500-530 M (guía inicial)	TAVR ≈4.500 M; TMTT ≈545 M (estimación); BPA ajustado 2,56 USD, 1,2 % bajo el consenso	Sí
2026	BPA ajustado 2,80-2,95 USD (dic-2025), elevado a 2,90-3,05 (ene) y 2,95-3,05 (abr); ventas +8-10 % elevadas a +10-11 %	En curso: 1S26 con BPA ajustado de 1,56 USD y ventas +15 %	Parcial

Dirección creíble en ventas: ha subido la guía de 2026 tres veces. En beneficio, falló el 4T25 por gasto. El relevo del director financiero, si se confirma, es el principal punto a vigilar. No pudimos leer el proxy de 2026 (sin red) para las participaciones de los directivos.

14. Gobierno corporativo

Confianza: Baja

Consejeros	**0**		
		Criterios de buen gobierno cumplidos	**7 de 13 (5 sin dato)**
Cambios de presidente o primer ejecutivo (24 meses)	**0**		

Criterio	Dato	Resultado
Consejeros independientes ≥ 50 % (≥ 33 % si hay accionista de control)	Sin dato	Sin dato
Presidencia sin vínculo familiar ni profesional con el accionista de control	Sin control	Cumple
Presidente no ejecutivo, o consejero coordinador independiente	No ejecutivo	Cumple
Comisión de auditoría con mayoría de independientes y presidida por uno	Sí	Cumple
Ningún consejero «otro externo» con más de 12 años	Sin dato	Sin dato
Estabilidad de la cúpula: como mucho un cambio de presidente o primer ejecutivo en 24 meses	0 cambios	Cumple
Peor voto a favor sobre remuneración (3 juntas) ≥ 80 %	Sin dato	Sin dato
Variable a largo plazo ligado a rentabilidad (ROIC, TSR, FCF)	Sin dato	Sin dato
Una acción, un voto, sin blindajes ni límites de voto estatutarios	Sí	Cumple
Sin operaciones vinculadas relevantes	No hay	Cumple
Auditor con 10 años o menos en el cargo	Sin dato	Sin dato
Opinión de auditoría sin salvedades	Favorable	Cumple
Directivos compradores netos en 12 meses (o sin ventas relevantes)	Compras 0,00 / ventas 0,05 M	No cumple

Compras y ventas de consejeros y directivos (12 meses)

Fecha	Persona	Operación	Acciones	Importe (M)
8 oct 2026	Daniel Lippis (vicepresidente)	Venta	619	0,05

Remuneración

El proxy de 2026 (DEF 14A, 26-mar-2026) describe una política de pago por resultados ligada a la estrategia a largo plazo y somete la remuneración a voto consultivo en la junta de mayo [25]. No pudimos leer las tablas de remuneración ni el resultado del voto (sin acceso a sec.gov).

Operaciones vinculadas, estructura de control y defensas

Capital disperso sin accionista de control, una sola clase de acciones. Según la prensa, Mike Mussallem dejó la presidencia en 2024 y le sucedió un consejero independiente (Nicholas Valeriani); no está confirmado con el proxy de 2026 [27].

Señales de alerta

- Posible relevo del director financiero en 2026, sin sucesor confirmado en las fuentes leídas [26].

Parte IV — Mercado y valoración

15. Previsiones de la compañía y consenso

Confianza: Media

Guía 2026 (confirmada y subida el 23-jul-2026): ventas +10-11 % a divisa constante (antes 9-11 %), 6.600-6.900 M; TAVR 4.750-5.000 M (+8-9 % a divisa constante); TMTT 760-780 M; BPA ajustado 2,95-3,05 USD (+17 % en el punto medio) con un tipo impositivo del 16-19 % [5, 33]. No hay guía pública de 2027; la empresa la suele dar en su conferencia de inversores de diciembre. Resultados del 3T26 el 4-nov-2026 y acto con inversores en TCT el 2-nov, con los datos del ensayo PROGRESS [29].

Periodo	Ingresos	BPA	DPA	Fuente
2026e	6.780	3,00	0,00	Stock Analysis (S&P Global), 28 analistas, 6-oct-2026 [38]; ventas: punto medio aproximado de la guía
2027e	7.320	3,38	0,00	Stock Analysis (BPA, 6-oct) [38]; Yahoo Finance (ventas, 30 analistas, feb-2026) [32]

Nuestra proyección frente al consenso

Periodo	Ingresos propios	Ingresos consenso	Dif.	EBITDA propio
2026e	6.796	6.780	+0,2 %	2.107
2027e	7.441	7.320	+1,7 %	2.344

Analistas	**28**		
Precio objetivo medio	**101,59**	Rango de precios objetivo	**81,00 – 110,00**

Revisiones de estimaciones

El BPA de 2027e subió de 3,30 USD (Yahoo, febrero) a 3,38 (Stock Analysis, octubre) tras dos trimestres por encima de lo esperado [32, 38]. Los objetivos subieron en julio-octubre: UBS inició en Comprar con 110 USD (28-jul) y lo reiteró en octubre, Leerink subió a Outperform con 101 USD y Bernstein subió a 99 USD manteniendo Market Perform [30, 31, 43]. El objetivo medio pasa de ≈96,5 USD en febrero a 101,6 USD en octubre. Solo encontramos una fuente con estimaciones completas; el objetivo y las recomendaciones se contrastan con Benzinga y StreetInsider.

17. Múltiplos frente a su historia

Confianza: Media

Múltiplo	Actual	Mediana	Mínimo	Máximo	Percentil	Prima / descuento
EV/EBITDA últimos 12 meses (cierre de cada año)	22,9x	31,6x	27,0x	32,6x	0 %	-28 %
PER últimos 12 meses (cierre de cada año)	47,6x	38,1x	31,8x	47,4x	100 %	+25 %

El PER adelantado (cierre del año ÷ BPA ajustado del siguiente) pasó de 41x en 2020 y 52x en 2021 a 28,5-29,7x en 2022-2025 [34, 35, 42]: el mercado dejó de pagar la prima de crecimiento cuando TAVR se frenó en 2023-24 (un dígito medio) y no la ha devuelto con la aceleración de 2025-26. Hoy cotiza a 26,5x nuestro BPA de 2027e, un 9 % por debajo de su mediana de cinco años (29,1x): es la primera vez desde 2019 que está por debajo de su rango reciente. Los PER de los últimos 12 meses que calcula el motor sobre el BPA contable (con cargos) no son comparables y no se usan.

18. Comparables cotizados

Confianza: Media

Fabricantes estadounidenses de tecnología médica de gran capitalización con los que compite por el capital de los mismos fondos: Medtronic, Abbott y Boston Scientific (también rivales en corazón estructural), Stryker y Zimmer, Intuitive (crecedor de calidad), Dexcom, Insulet, IDEXX y ResMed (consumible recurrente). Cifras del informe de Intuitive del repo a 6-oct-2026 (MarketScreener y Stock Analysis), sin cambios [36].

Empresa	País	Capitaliz.	EV/Vtas	EV/ EBITDA LTM	EV/ EBITDA NTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC	DN/ EBITDA	FCF yield
Edwards	US	49.432	7,0x	22,9x	–	26,0x	+8,1 %	30,7 %	15,7 %	-1,8x	2,7 %
Stryker	US	106.710	4,6x	16,3x	14,2x	17,1x	+12,3 %	28,1 %	12,5 %	1,6x	4,4 %
Boston Scientific	US	61.140	3,5x	11,8x	10,9x	12,5x	+4,9 %	29,8 %	11,2 %	1,9x	6,0 %
Medtronic	IE	111.400	3,5x	12,6x	11,7x	14,1x	+5,5 %	27,6 %	8,6 %	1,9x	5,5 %
Abbott Laboratories	US	169.850	4,2x	16,1x	14,0x	16,5x	+14,9 %	26,5 %	7,5 %	2,2x	4,6 %
Dexcom	US	31.470	6,2x	21,9x	18,5x	27,7x	+14,0 %	25,7 %	44,5 %	-0,4x	4,4 %
Insulet	US	9.340	3,2x	14,8x	12,1x	18,1x	+18,9 %	21,3 %	21,3 %	0,6x	3,1 %
IDEXX Laboratories	US	40.610	9,1x	25,7x	22,9x	31,6x	+10,7 %	35,0 %	47,2 %	0,6x	3,1 %
ResMed	US	31.040	5,4x	13,8x	13,3x	17,8x	+4,4 %	41,2 %	26,2 %	-0,3x	5,3 %
Zimmer Biomet	US	17.110	2,9x	8,8x	8,4x	10,0x	+3,8 %	32,7 %	6,2 %	2,6x	7,0 %
Intuitive Surgical	US	144.297	–	–	28,6x	39,2x	+13,2 %	37,9 %	30,2 %	–	–

La primera fila es la empresa analizada (calculada con sus propios datos). Los estadísticos excluyen a la empresa.

Estadístico	EV/Vtas	EV/EBITDA LTM	EV/EBITDA NTM	PER NTM	Crec.	M. EBITDA	ROIC
Mediana	4,2x	14,8x	13,7x	17,5x	+11,5 %	29,0 %	16,9 %
Media	4,7x	15,8x	15,5x	20,5x	+10,3 %	30,6 %	21,5 %
Percentil 25	3,5x	12,6x	11,8x	14,7x	+5,1 %	26,8 %	9,3 %
Percentil 75	5,4x	16,3x	17,4x	25,3x	+13,8 %	34,4 %	29,2 %

Valor implícito por acción

Múltiplo aplicado	Métrica de la empresa	Múltiplo p25 / mediana / p75	Valor p25	Valor mediana	Valor p75	Potencial
EV/EBITDA últimos 12 meses	1.997	12,6x / 14,8x / 16,3x	49,99	57,62	62,81	-32,8 %
PER próximos 12 meses	3,3	14,7x / 17,5x / 25,3x	48,49	57,56	83,46	-32,9 %
EV/Ventas últimos 12 meses	6.513	3,5x / 4,2x / 5,4x	45,66	54,14	67,13	-36,9 %



Edwards cotiza a 26,0x el BPA de los próximos 12 meses frente a una mediana de 17,5x de los grandes de tecnología médica, con un crecimiento parecido (11,7 % frente a 11,5 % de mediana) y un margen EBITDA similar [36]. La prima (≈50 %) no la explican el crecimiento ni el margen: es la duración del crecimiento de TAVR y la caja neta. Solo Intuitive (39,2x), IDEXX (31,6x) y Dexcom (27,7x) cotizan más caros. Los comparables (57,56 USD por acción en la mediana del PER) dicen cuánto valdría Edwards como un líder maduro; por eso pesan solo un 10 % en la síntesis. Las cifras son del 6-oct (informe de Intuitive) y no se han actualizado al 13-oct.

19. Transacciones precedentes

Confianza: Media

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	Prima	Comentario
2026-01	Penumbra	Boston Scientific	14.500	10,36x	19 %	Trombectomía y vascular. 374 USD por acción (73 % en efectivo, 27 % en acciones de BSX); EV ≈ 14.500 M; ventas 2025 ≈ 1.400 M (+17,3 %-17,5 %). Prima frente al cierre del 14-ene-2026 (313,43 USD). Cierre previsto en 2026. [36]
2025-11	Exact Sciences	Abbott Laboratories	23.000	7,13x	–	Diagnóstico oncológico. 105 USD por acción en efectivo; precio de las acciones 21.000 M y EV ≈ 23.000 M; ventas 2025 estimadas 3.220-3.235 M (punto medio). Cierre previsto en el 2T26. [36]
2025-07	Monogram Technologies	Zimmer Biomet	168	–	–	Robótica ortopédica semiautónoma (rodilla). 4,04 USD por acción en efectivo, EV ≈ 168 M, más CVR de hasta 12,37 USD por acción; sin ventas significativas. [36]
2025-01	Paragon 28	Zimmer Biomet	1.200	4,69x	–	Pie y tobillo. 13,00 USD por acción en efectivo más CVR de hasta 1,00 USD; precio de las acciones ≈ 1.100 M y EV ≈ 1.200 M; ventas 2024 de 255,9-256,2 M (+18 %). [36]
2025-01	Inari Medical	Stryker	4.789	8,34x	–	Trombectomía venosa. 80 USD por acción en efectivo; valor de las acciones totalmente diluido ≈ 4.900 M. EV y ventas de 12 meses a sep-2024 calculados con las cuentas de Inari: caja e inversiones 111,5 M, sin deuda; ventas 574,5 M (estimación propia). [36]

Fecha	Objetivo	Comprador	EV (M)	EV/ Ventas	Prima	Comentario
2024-06	Silk Road Medical	Boston Scientific	1.161	6,26x	38 %	Revascularización carotídea (TCAR). 27,50 USD por acción en efectivo; valor de las acciones ≈ 1.260 M; prima del 38 % sobre la media ponderada de 60 días. EV y ventas de 12 meses a mar-2024 con las cuentas de Silk Road: caja e inversiones 174,4 M, deuda 75,9 M, ventas 185,5 M (estimación propia). [36]
2024-04	Shockwave Medical	Johnson & Johnson	13.100	17,94x	–	Litotricia intravascular. 335 USD por acción en efectivo; EV ≈ 13.100 M incluida la caja; ventas 2023 de 730,2 M. [36]
2024-01	Axonics	Boston Scientific	3.400	9,29x	–	Neuromodulación sacra (urología). 71 USD por acción en efectivo; valor de las acciones ≈ 3.700 M y EV ≈ 3.400 M; ventas 2023 ≈ 366 M (+34 %). [36]
2022-11	Abiomed	Johnson & Johnson	16.600	16,09x	–	Asistencia cardiaca (Impella). 380 USD por acción en efectivo más CVR de hasta 35 USD; EV ≈ 16.600 M incluida la caja; ventas del ejercicio a mar-2022 de 1.031,8 M. [36]
2024-07	JenaValve (y Endotronix)	Edwards Lifesciences	–	–	–	Bloqueada por la FTC (medida cautelar de enero de 2026); importe no publicado en las fuentes leídas [37].

		Prima de control mediana	**29 %**
Valor por acción implícito (mediana de EV/ventas)	**105,94**	Rango p25 – p75	**84,45 – 139,59**

Las compras de tecnología médica de crecimiento se pagan a 6-18 veces las ventas (Shockwave 17,9x, Abiomed 16,1x, Penumbra 10,4x) [36]. Edwards no es objetivo plausible: capitalización de ≈50.000 M y un comprador natural (Medtronic, Abbott, Boston) chocaría con la FTC, que ya bloqueó la compra de JenaValve por la propia Edwards [37]. Las transacciones no pesan en la valoración.

20. Descuento de flujos de caja (DCF)

Confianza: Baja

Supuestos y su justificación

Crecimiento de ingresos.

2026e +12,0 % (fijo): 1S26 +15 % y guía de +10-11 % a divisa constante con la divisa a favor [5, 6]. 2027-28e +9,5 % anual: TAVR +7-8 % (nueva cobertura de Medicare sin requisitos de volumen de los hospitales, más el efecto de EARLY TAVR) y TMTT +30-40 % sobre una base de ≈770 M [5, 19]. El consenso da 7.320 M en 2027e (+8 %); nosotros 7.441 M (+1,7 %) [32]. Después baja de forma lineal hasta el 3,5 % en 2035e, cerca del terminal: TAVR madura y TMTT pasa a crecer al ritmo del mercado.

Márgenes.

Margen EBITDA contable (con remuneración en acciones y con parte de los cargos de litigios y de I+D comprada, que se repiten): 23,4 % en 2025 con los cargos de JenaValve y litigios y 30,7 % en los 12 meses a junio de 2026 [3, 36]. Proyectamos el 31 % en 2026e (BPA de 2,92 USD frente a la guía ajustada de 2,95-3,05) y una subida hasta el 33 % en 2030e por la escala de TMTT, hoy con margen bajo. El margen operativo ajustado del 4T25 fue del 23,7 % y el de la guía de 2026, mayor [3].

Inversión y circulante.

Capex del 4,3 % de las ventas hasta 2028e (260 M en 2025, ampliación de fábricas) y 3,8 % después; amortización del 2,6 % (estimación). Circulante del 29 % de las ventas: existencias (1.126 M) y clientes (660 M) a cierre de 2025 sobre ventas de 6.068 M [8]. El I+D (≈17 % de las ventas) va dentro del margen como gasto.

Coste del capital.

Tasa libre del 5,22 % (bono del Tesoro a 10 años del 13-oct) [41], beta de 1,0 (ninguna beta de fuente primaria disponible; la de los grandes de tecnología médica ronda 0,8-1,1), prima de mercado del 5,0 % y sin prima adicional. Deuda testimonial (598,7 M frente a 49.432 M de capitalización): coste del 4,3 % y peso del 1 %. WACC del 10,15 %. Con la prima implícita del mercado (4,20 %) [40], el WACC baja al 9,4 %. La recomendación depende poco de la beta porque la manda la regla a 12 meses.

Valor terminal.

Crecimiento a perpetuidad del 3,0 %: inflación en USD (≈2,5 %) y algo de volumen por envejecimiento; por debajo de la tasa libre menos medio punto. El valor terminal pesa un 57 % del valor. El múltiplo de salida de contraste (18x EBITDA) es el de los grandes de tecnología médica con crecimiento parecido.

Coste medio ponderado del capital

Componente	Valor
Tasa libre de riesgo	5,22 %
Beta	1,00
Prima de riesgo de mercado	5,00 %
Prima adicional (país, tamaño, específica)	0,00 %
Coste de los fondos propios	10,22 %
Coste de la deuda antes de impuestos	4,30 %
Tipo impositivo	17,00 %
Coste de la deuda después de impuestos	3,57 %
Peso de la deuda (D / (D + E))	1,00 %
WACC	10,15 %
Prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa)	4,20 %
WACC con la prima implícita del mercado	9,36 %

Proyección

Año	Ingresos	Crec.	EBITDA	M. EBITDA	Amort.	Impuestos	Capex	Δ Circ.	FCFF	Fracción	VA
2026e	6.796	12,0 %	2.107	31,0 %	177	328	292	185	1.301	0,21	275
2027e	7.441	9,5 %	2.344	31,5 %	193	366	320	187	1.471	1,00	1.372
2028e	8.148	9,5 %	2.607	32,0 %	212	407	350	205	1.645	1,00	1.393
2029e	8.882	9,0 %	2.887	32,5 %	231	451	337	213	1.885	1,00	1.449
2030e	9.637	8,5 %	3.180	33,0 %	251	498	366	219	2.097	1,00	1.463
2031e	10.359	7,5 %	3.419	33,0 %	269	535	394	210	2.280	1,00	1.444
2032e	11.033	6,5 %	3.641	33,0 %	287	570	419	195	2.456	1,00	1.413
2033e	11.639	5,5 %	3.841	33,0 %	303	602	442	176	2.621	1,00	1.368
2034e	12.163	4,5 %	4.014	33,0 %	316	629	462	152	2.771	1,00	1.313
2035e	12.589	3,5 %	4.154	33,0 %	327	651	478	123	2.902	1,00	1.249

FCFF = EBIT × (1 − t) + amortizaciones − capex − variación del circulante. «Fracción» es la parte del ejercicio que queda por delante desde la fecha de valoración; VA, el valor actual.



Valor terminal

Concepto	Valor
Método principal	Crecimiento a perpetuidad
Crecimiento a perpetuidad	3,0 %
Múltiplo EV/EBITDA de salida	18,0x
Valor terminal (Gordon)	41.783
Valor terminal (múltiplo)	74.778
Múltiplo de salida implícito en Gordon	10,1x
Crecimiento implícito en el múltiplo	6,04 %
Peso del valor terminal en el valor empresa	57 %

Del valor empresa al valor por acción

Concepto	Importe
Valor actual de los flujos proyectados	12.741
Valor actual del valor terminal	17.143
Valor empresa	29.883
– Deuda financiera neta (con arrendamientos)	3.654
– Minoritarios, pensiones y otros; + asociadas	0
Valor de los fondos propios	33.538
Acciones diluidas (millones)	576,4
Valor por acción	58,18



Sensibilidad: WACC × Crecimiento a perpetuidad

WACC	2,0 %	2,5 %	3,0 %	3,5 %	4,0 %
9,2 %	61,42	63,99	66,99	70,51	74,72
9,7 %	57,61	59,77	62,25	65,14	68,53
10,2 %	54,28	56,11	58,18	60,57	63,35
10,7 %	51,35	52,90	54,66	56,66	58,96
11,2 %	48,74	50,07	51,57	53,26	55,19

Sensibilidad: margen EBITDA × crecimiento de ingresos (desplazamiento de toda la proyección)

Margen \ crec.	-2 pp	-1 pp	0 pp	+1 pp	+2 pp
-2 pp	49,41	51,83	54,39	57,09	59,95
-1 pp	51,07	53,61	56,28	59,12	62,12
0 pp	52,74	55,38	58,18	61,15	64,29
+1 pp	54,40	57,16	60,08	63,18	66,46
+2 pp	56,06	58,94	61,98	65,21	68,63

¿Puede la empresa sostener el crecimiento previsto?

Veredicto: Sí.

Prueba	Valor
Crecimiento medio de ingresos proyectado	7,6 %
Capex bruto medio (incluidas compras si van como inversión)	3,9 % de las ventas
Reinversión neta acumulada (capex − amortización + circulante)	3.159 M (13 % del NOPAT)

La proyección apenas necesita inversión neta de la amortización (reinversión acumulada de 3.159 M, el 13 % del NOPAT, con un capex bruto medio del 3,9 % de las ventas). En un negocio de activos ligeros, el crecimiento medio del 7,6 % tiene que salir de subir precios y de ganar volumen sin capital nuevo, y la prueba es el poder de precios y la

cuota; en un comprador en serie, la amortización es de intangibles comprados y la prueba es el capex bruto (las compras) frente al crecimiento comprado.

Año	Volumen	Precio	Otros (mezcla, compras)	Crecimiento	De dónde sale
2026e	+10,5 %	0,0 %	+1,5 %	+12,0 %	Volumen: procedimientos de TAVR (+8-9 % a divisa constante en la guía) y TMTT (+40 %); precio medio estable según la dirección; 1,5 puntos de divisa a favor en el 1S26 [5, 6].
2027e	+9,5 %	0,0 %	0,0 %	+9,5 %	Volumen: primer año completo de la nueva cobertura de Medicare (sin requisitos de volumen de hospital ni registro obligatorio en sintomáticos) y de la indicación en asintomáticos [19, 20]; TMTT +30-35 %.
2028e	+9,5 %	0,0 %	0,0 %	+9,5 %	Volumen: TAVR +7 % y TMTT +30 %; sin subidas de precio (el reembolso de Medicare limita el precio).
2029e	+9,0 %	0,0 %	0,0 %	+9,0 %	Volumen: estenosis moderada si PROGRESS es positivo (resultados el 3-nov-2026), que no está en el caso base más allá de un punto.
2030e	+8,5 %	0,0 %	0,0 %	+8,5 %	Volumen: TAVR madura hacia el crecimiento del mercado (≈7-8 %) y TMTT hacia el 20 %.

La proyección no necesita capital nuevo relevante: la reinversión neta es el 13 % del NOPAT (circulante y algo de capacidad) y el motor no puede hacer la prueba de financiación, así que la hacemos con la cuota. TAVR crece en nuestro base un 7-8 % al año en 2027-30, por debajo del 9,9 % previsto para el mercado [18]: la cuota de Edwards (más del 55 %) [17] se mantiene o baja ligeramente. El precio no aporta crecimiento (estable), así que todo depende del volumen, que tiene tres palancas con fecha y evidencia: cobertura de Medicare finalizada el 10-sep-2026 [19], indicación en asintomáticos [23] y TMTT con crecimientos del 45-60 % [5, 6]. El crecimiento lo financia el I+D, que ya va en gastos. Veredicto: Sí, sin rebajar el base.

DCF inverso: qué descuenta el precio actual

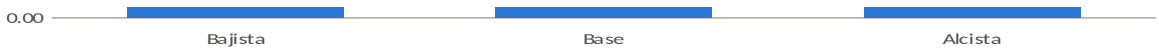
Crecimiento anual implícito en el precio (2027e-2035e)	**14,8 % (base: 7,1 %)**
Margen EBITDA final implícito	**47,5 % (base: 33,0 %)**
Rentabilidad anual implícita (TIR al precio actual)	**7,7 % (WACC: 10,2 %)**

El DCF da 58,18 USD por acción, un 32,2 % por debajo del precio, con un valor terminal del 57 %. El DCF inverso dice que el precio de 85,76 USD descuenta un crecimiento medio del 14,8 % anual en 2027-35, el doble de nuestro 7,1 %, o una rentabilidad implícita del 7,7 % frente a nuestro WACC del 10,15 %. Es exigente: Edwards no crece al 15 % desde antes de 2020. La diferencia es sobre todo de tasa: con la prima implícita del mercado el valor sube, pero tampoco llega al precio. El mercado paga a Edwards como empresa de crecimiento largo (TAVR en nuevas indicaciones y TMTT), con un descuento implícito del 7-8 %, típico de los grandes de tecnología médica de calidad. Por eso el valor intrínseco queda por debajo del precio y del objetivo a 12 meses: la acción no está barata en términos absolutos, aunque sí frente a su propia historia de múltiplos.

21. Escenarios

Confianza: Baja

Escenario	Prob.	Crec. medio	Margen final	WACC	Valor	Potencial	Qué tiene que ocurrir
Bajista	25 %	4,1 %	31,0 %	10,2 %	45,58	-46,9 %	Medtronic y Abbott ganan cuota en los hospitales nuevos que abre la cobertura de Medicare y la indicación en asintomáticos tarda en llegar al reembolso: TAVR crece un 4-5 % y el margen se queda en el 30 %, como en 2023-24 cuando TAVR se frenó por capacidad.
Base	50 %	7,1 %	33,0 %	10,2 %	58,18	-32,2 %	TAVR crece un 7-8 % con la nueva cobertura y TMTT un 30-40 %; el margen sube un punto por año hasta el 33 % con la escala de TMTT.
Alcista	25 %	9,1 %	34,0 %	10,2 %	66,46	-22,5 %	PROGRESS sale positivo en TCT y los asintomáticos se cubren pronto: TAVR crece a dos dígitos y TMTT llega a rentabilidad antes, con el margen un punto por encima del base.



Valor ponderado por probabilidad: 57,10 USD (-33,4 %).

En el DCF los tres escenarios quedan por debajo del precio (45,58, 58,18 y 66,46 USD): con una tasa del 10,15 % ni el alcista justifica la cotización. A 12 meses, con nuestro BPA y la regla de múltiplos v3, la asimetría es favorable (2,32x): el bajista pierde un 17,7 % y el alcista gana un 41 %. Las dos lecturas no se contradicen: el mercado aplica a Edwards una tasa más baja que la nuestra, y mientras la mantenga, el beneficio que crece al 11-12 % anual empuja el precio.

22. Suma de partes

Confianza: Media

No aplica: TAVR, TMTT y Surgical comparten clientes, canal y fábricas, y la empresa no publica el resultado de cada línea.

23. Síntesis de valoración

Confianza: Baja



Método	Mínimo	Central	Máximo
Cotización 52 semanas	72,30	85,76	96,29
Precio objetivo de los analistas	81,00	101,59	110,00
Comparables: PER NTM	48,49	57,56	83,46
Transacciones precedentes (EV/ventas)	84,45	105,94	139,59
DCF (WACC y g ± 0,5)	52,90	58,18	65,14
Escenarios (bajista – alcista)	45,58	57,10	66,46
DCF con la prima del mercado	60,49	64,93	70,14
Precio actual	85,33	85,76	86,19

Método	Valor por acción	Potencial	Peso
DCF	58,18	-32,2 %	50 %
Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)	57,56	-32,9 %	10 %
Transacciones precedentes (no se usa)	105,94	+23,5 %	0 %
Escenarios ponderados	57,10	-33,4 %	40 %

Valor intrínseco ponderado (largo plazo): 57,69 USD (-32,7 % sobre 85,76).

Pesos: DCF 50 %, escenarios 40 % y comparables 10 %. El DCF es el método que mejor recoge un crecimiento de diez años, pero a nuestra tasa (10,15 %) castiga a una empresa que el mercado descuenta al 7,7 %. Los comparables (PER de 17,5x) valoran a Edwards como un líder maduro y quedan lejos; las transacciones (105,94 USD de mediana) incluyen prima de control y una compra de Edwards es poco probable por la competencia, así que pesan cero. La dispersión entre métodos (de 57,56 a 105,94 USD) muestra que el valor depende de la tasa de descuento más que de las cifras: el valor objetivo de la síntesis (57,69 USD) es el de una empresa de calidad a precio exigente.

Objetivo a 12 meses: nuestro PER × nuestro BPA

Escenario	BPA	PER	De dónde sale el PER	Precio	Rentabilidad
Bajista	3,18	22,2x	base × 0.8	70,60	-17,7 %
Base	3,59	27,7x	PER actual (26.5x) a mitad de camino hacia la mediana de 5 años (29.1x)	99,44	+16,0 %
Alcista	3,84	31,5x	media histórica larga	120,96	+41,0 %

Objetivo a 12 meses (ponderado): 97,61 USD · rentabilidad +13,8 % (base +16,0 %) · señal Mantener.

Frente al consenso (solo contraste).

Nuestro BPA de 2027e (3,24 USD) queda un 4 % por debajo del consenso (3,38) [38] porque contamos como recurrentes parte de los cargos que la empresa excluye (≈0,10 USD por acción). En 2028e no hay consenso fiable gratis. Nuestro precio base (99,44 USD) queda un 2,1 % por debajo del objetivo medio de los analistas (101,59 USD; 81-110) [29, 31]: el múltiplo que aplica la regla (27,7x) es parecido al que implican los objetivos (≈28-30x el BPA de 2027e).

Del valor intrínseco al objetivo a 12 meses.

El objetivo a 12 meses (97,61 USD ponderado) queda un 69 % por encima del valor intrínseco del DCF (57,69 USD de la síntesis). La distancia es de tasa de descuento: el mercado lleva cuatro años pagando 28-30 veces el BPA del año siguiente por Edwards, que equivale a una rentabilidad implícita del 7-8 %, y nuestra regla supone que eso sigue un año más (con el PER subiendo a mitad de camino de su mediana). Para cerrar la distancia con el DCF haría falta que el mercado exigiera nuestra rentabilidad del 10 % (caída del múltiplo a ≈17-18x, el de los comparables) o que el crecimiento durara mucho más que en nuestro base. La tesis a 12 meses es de beneficio y de múltiplo, no de valor intrínseco.

Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento

24. Catalizadores

Confianza: Media

Fecha	Evento	Qué se sabrá	Prob.	Sentido
2026-11-02/03	TCT: resultados del ensayo PROGRESS (TAVR en estenosis moderada) y acto con inversores	Positivo abriría un mercado nuevo a varios años; negativo quitaría parte de la prima	Media	+/−
2026-11-04	Resultados del 3T26	Primer trimestre tras la cobertura de Medicare; la guía de 2026 (BPA 2,95-3,05) podría subir	Alta	+
2026-12	Conferencia anual de inversores: guía de 2027	Si la guía de ventas de 2027 es ≥10 %, confirma nuestro base	Alta	+/−
2027-1S	Aprobación de estudios CED para asintomáticos (Medicare)	Activa la cobertura de los asintomáticos	Media	+
2027-02	Resultados del 4T26 y del año	Prueba del margen con TMTT a escala	Alta	+/−

25. Riesgos y pre-mortem

Confianza: Media

#	Riesgo	Tipo	Prob.	Impacto	Efecto en valor	Mitigante	Señal de alerta
1	**Pérdida de cuota en TAVR frente a Medtronic y Abbott en los hospitales nuevos**	Competencia	Media	Alto	−18 % (bajista a 12 meses)	Evidencia clínica de durabilidad y salida de Boston Scientific	Crecimiento de TAVR a divisa constante por debajo del 6 % dos trimestres seguidos
2	**Retraso de la cobertura de los asintomáticos (no hay estudios CED aprobados)**	Regulación	Media	Medio	−5 a −10 %	La cobertura de sintomáticos sin requisitos ya está en vigor	Sin estudios CED aprobados a mediados de 2027
3	**PROGRESS negativo o ambiguo en TCT**	Clínico	Media	Medio	−5 a −10 % (la prima de opción)	No está en nuestro caso base	Objetivo primario no alcanzado el 3-nov-2026
4	**Compresión del múltiplo hacia los comparables (17-18x)**	Mercado	Baja	Alto	−35 % (el DCF está en 58 USD)	Crecimiento de dos dígitos del BPA	PER adelantado por debajo de 22x
5	**Litigios de patentes y cargos recurrentes**	Legal	Alta	Bajo	−2 a −4 %	Historial de acuerdos	Cargos fuera del BPA ajustado por encima de 0,15 USD por acción al año
6	**TMTT no llega a rentabilidad**	Operativo	Media	Medio	−8 % (margen 2 puntos por debajo)	Crecimiento del 45-60 % que diluye costes fijos	Margen operativo ajustado del grupo sin mejora en 2027

Pre-mortem

Octubre de 2029: la acción ha caído un 40 %, a ≈52 USD. Lo que pasó: la nueva cobertura de Medicare abrió decenas de hospitales pequeños en 2027, y Medtronic y Abbott, con precios más bajos y su válvula autoexpandible, se llevaron la mayoría. TAVR de Edwards creció un 4 % en 2027 y un 3 % en 2028 mientras el mercado crecía al 9 %. PROGRESS dio un resultado ambiguo y los asintomáticos tardaron dos años en entrar en un estudio CED. TMTT siguió creciendo, pero su margen no compensó el frenazo de TAVR. Con el BPA creciendo al 5 %, el mercado dejó de pagar 28x y pasó a 18x, el múltiplo de los comparables. La señal temprana habría sido el crecimiento de TAVR a divisa constante por debajo del 6 % en el 2T27, con la dirección hablando de «presión competitiva en cuentas nuevas».

26. ESG y controversias

Confianza: Baja

Asuntos materiales

Lo material es la seguridad del paciente y la calidad del producto (retiradas, durabilidad de las válvulas) y el acceso al tratamiento (reembolso). La empresa publica datos de durabilidad a largo plazo de SAPIEN, su principal argumento comercial [22].

Controversias

Litigios de patentes recurrentes con competidores (cargos casi todos los años) y la demanda de la FTC contra la compra de JenaValve, perdida por Edwards en enero de 2026 [16]. No encontramos sanciones de producto relevantes en tres años.

27. Preguntas abiertas para la dirección y la due diligence

Confianza: Media

#	Tema	Pregunta	Por qué importa
1	**Cobertura de Medicare**	¿Cuántos hospitales nuevos esperan que abran programas de TAVR en 2027 y qué cuota esperan en ellos?	Es la palanca del crecimiento de 2027-28 y el riesgo de cuota del bajista.
2	**Asintomáticos**	¿Qué estudios CED están en preparación y cuándo esperan la aprobación de CMS?	Sin ellos la cobertura de asintomáticos no se activa.
3	**Margen de TMTT**	¿En qué año alcanza TMTT el margen operativo del grupo?	Sube el margen del caso base del 31 % al 33 %.
4	**Cargos recurrentes**	¿Por qué los litigios y la I+D comprada se excluyen del BPA ajustado si se repiten cada año?	Distancia de ≈0,75 USD por acción entre contable y ajustado en 2025.
5	**Caja**	¿Qué uso darán a los ≈3.650 M de caja neta tras el bloqueo de JenaValve?	Recompras al precio actual crearían poco valor según el DCF.
6	**Director financiero**	¿Está confirmado el relevo del director financiero y quién lo sucede?	Cambio de la cúpula financiera en un año de guía nueva.

28. Sentimiento en foros y comentarios

Confianza: Baja

Tono: Dividido · **Tendencia:** Mejora

Dónde	Fecha	Comentarios	Tono	Qué se dice
Simply Wall St (narrativas de la comunidad)	2026-09	3	Positivo	La narrativa más seguida sitúa el valor razonable en ≈97 USD con la acción cerca de 85 y apoya la tesis en las ganancias de cuota en TAVR, el crecimiento de dos dígitos y la mejora del margen [45].
Webull (noticias y comentarios sobre la cobertura de Medicare)	2026-09	4	Dividido	Debate sobre si la nueva cobertura de TAVR cambia la tesis: unos ven más volumen en 2027 y otros recuerdan que los asintomáticos solo se cubren dentro de estudios que aún no existen [46].
Quiver Quant (resúmenes de movimientos diarios)	2026-09	2	Negativo	Una caída del día se lee como «vender con la noticia» tras la cobertura de Medicare y recogida de beneficios antes de resultados [47].
TIKR (blogs de inversores con modelos propios)	2026-08	2	Positivo	Modelos con objetivos de 103 USD a un año y ≈149 USD a cinco años, apoyados en TMTT: dicen que el mercado valora a Edwards como empresa de un solo producto [48].
MarketBeat (alertas, resumen de la conferencia del 2T26 y ventas de directivos)	2026-10	3	Neutro	Los lectores destacan la subida de la guía y la salida de un competidor de TAVR; ventas pequeñas de directivos en octubre sin lectura clara [21].

Tema	Postura	Peso	Qué dicen los datos
Cobertura de Medicare y pacientes asintomáticos	Dividida	Alto	Los datos dan la razón a los prudentes: el ACC dice que los asintomáticos aún no están cubiertos fuera de estudios CED; el efecto en volumen llegará en 2027 o después y no está en nuestro caso base más allá de un 9-10 % de crecimiento.
Ensayo PROGRESS (estenosis moderada) en TCT	Alcista	Medio	Catalizador binario con fecha (3-nov-2026); un resultado positivo abre un mercado nuevo a varios años, no al de 12 meses.
TMTT como segundo motor	Alcista	Medio	Crecimiento del 45-60 % confirmado en 2026; pesa ≈11 % de las ventas y aún no aporta margen: mueve el valor a largo plazo más que el BPA de 2028.
Valoración frente a la historia	Dividida	Medio	El PER adelantado de ≈26x está por debajo de la mediana de 28-30x de 2022-2025 pero muy por encima de los comparables (≈18x): las dos lecturas son correctas.

El inversor particular ha pasado de negativo (2023-24) a dividido: la aceleración de TAVR y la cobertura de Medicare han mejorado el tono, pero los foros debaten si el catalizador ya está en el precio [45, 46, 47]. No hay euforia ni capitulación. El sentimiento no contradice a los analistas (mayoría Comprar, objetivo medio de 101,59 USD) ni añade un riesgo que el informe no recoja. El punto de alerta es que algunas narrativas leen la cobertura de los asintomáticos como inmediata, cuando el Colegio Americano de Cardiología dice que hoy no hay estudios aprobados que la activen [19].

Opiniones de inversores en foros, redes y comentarios de prensa: sirven para saber qué preocupa o entusiasma al mercado, no como fuente de cifras. No entran en la valoración.

Anexos

A. Controles de calidad del análisis

19 de 21 controles correctos y 2 explicados. Fuentes: 48 (11 primarias); citas distintas en el texto: 45.

Control	Resultado	Detalle
Tipo impositivo efectivo razonable (2023)	Explicado	11,1 %: explica la causa (créditos fiscales, regularizaciones, mezcla de países) y no lo proyectes en el DCF. Explicación: Tipo del 11,1 %: créditos fiscales de I+D y beneficios de fabricación en Singapur, Irlanda y Puerto Rico con tipos bajos. No se proyecta: el DCF usa el 17 %, dentro de la guía de 2026 (16-19 %) [5].
Tipo impositivo efectivo razonable (2024)	Explicado	9,8 %: explica la causa (créditos fiscales, regularizaciones, mezcla de países) y no lo proyectes en el DCF. Explicación: Tipo del 9,8 % por regularizaciones fiscales y la mezcla de países; el DCF usa el 17 % [5].
DCF inverso calculable	OK	–
Puente de ingresos (volumen + precio + otros) = crecimiento del DCF	OK	–
Circulante del primer año de proyección ≈ último real	OK	Supuesto 29,0 % frente a 29,4 % real: genera una variación de circulante de 185 M en el primer año. Converge de forma gradual.
Peso del valor terminal ≤ 80 % del valor empresa	OK	57 %.
Crecimiento a perpetuidad ≤ 3 %	OK	3,00 %.
Probabilidades de los escenarios suman 100	OK	–
Al menos 5 comparables	OK	10 comparables.
Pesos de la síntesis suman 100	OK	–
Múltiplos del objetivo a 12 m según la regla común	OK	–
Objetivo 12 m frente al consenso	OK	El base se separa un -2,1 % del objetivo medio de los analistas: explícalo en diferencia_consenso (nunca se acerca la cifra).
Precio del cierre de la fecha de corte (o de las dos sesiones anteriores)	OK	–
Recomendación coherente con la regla de decisión	OK	–
Convicción frente a la sugerida por los criterios	OK	Los criterios dan «Media» (Mantener con las dos reglas de acuerdo y lejos de los umbrales) y el análisis pone «Baja»: explica en la síntesis por qué te apartas.
La síntesis explica la convicción	OK	La síntesis debe decir por qué tiene esa convicción y qué la subiría o la bajaría.
Capitalización calculada ≈ publicada	OK	–
Al menos 25 fuentes	OK	48 fuentes (11 primarias).
Al menos 10 fuentes primarias	OK	11.
Toda cita [n] existe en fuentes	OK	–
Fuentes sin citar ≤ 15 %	OK	Sin citar: 28, 39, 44.

Tipo de fuente	Número
Primaria	11
Prensa	12
Datos de mercado	14
Sectorial	3
Analistas	4
Foros y redes	4

B. Información no disponible

Cuando un dato no aparece tras tres búsquedas distintas, el análisis lo deja fuera en lugar de estimarlo sin base. Las secciones de núcleo que faltan se avisan también en el resumen.

Sección no incluida	Tipo
16. Comportamiento en bolsa	Complemento

Sección	Dato que falta	Tipo	Las tres búsquedas	Decisión
financieros	Cuenta de 2019-2022 de operaciones continuadas y desglose de costes de 2025	Núcleo	1) 10-K 2025 en sec.gov (sin red); 2) búsqueda de la cuenta XBRL y de agregadores (Stock Analysis, FN2, Finboard); 3) reconstrucción desde el 10-K 2024: solo 2022-2024 en base continuada, sin el resultado operativo de 2022	Omitido
balance	Activo y pasivo corriente, fondo de comercio, proveedores y reservas	Núcleo	1) informe anual 2025 (extracto parcial); 2) Stock Analysis y Fintel; 3) 10-Q del 2T26	Omitido
flujos	Recompras de 2023-2024	Complemento	1) 10-K 2025; 2) agregadores de flujos; 3) prensa de la recompra acelerada	Omitido
sector	Serie del tamaño del mercado de TAVR y segunda fuente independiente	Núcleo	1) informes de la empresa (sin red); 2) GMI y Life Science Market Research vía búsqueda; 3) estimación propia desde la cuota de Edwards	Calculado y marcado como estimación
competencia	Ingresos y margen de los competidores en TAVR	Complemento	1) informes de Medtronic y Abbott (no desglosan TAVR con margen); 2) prensa sectorial; 3) agregadores	Omitido
gobierno	Consejo, remuneración del primer ejecutivo, voto de remuneración y accionistas significativos	Núcleo	1) proxy DEF 14A 2026 en sec.gov (sin red); 2) búsqueda de la tabla de remuneración y del 8-K de la junta; 3) prensa y directorios	Omitido
bolsa	Rentabilidades, beta, volatilidad y caída máxima	Complemento	1) bolsa.mjs sin red; 2) WebFetch a Yahoo bloqueado; 3) búsqueda web: solo cotizaciones sueltas	Omitido
consenso	Estimaciones de 2028e y EBITDA de consenso	Complemento	1) MarketScreener (sin red); 2) Yahoo y Stock Analysis vía búsqueda; 3) TIKR y Barchart	Omitido
sentimiento	Reddit, Stocktwits y comentarios de Seeking Alpha	Complemento	1) API de Stocktwits y RSS de Seeking Alpha (sin red); 2) búsqueda web de hilos de Reddit y Stocktwits; 3) agregadores de noticias con comentarios	Omitido
bolsa	Beta de la acción	Complemento	1) bolsa.mjs sin red; 2) Yahoo y Stock Analysis vía búsqueda; 3) Damodaran sectorial sin acceso	Calculado y marcado como estimación

Fuentes

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
1	Form 10-K del ejercicio 2025 (extractos de búsqueda: ventas, recompras, discontinuadas)	Edwards Lifesciences / SEC EDGAR	Primaria	13 feb 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099800/000109980026000009/ew-20251231.htm
2	Form 10-K del ejercicio 2024 (cuenta de operaciones continuadas 2022-2024, extracto XBRL)	Edwards Lifesciences / SEC EDGAR	Primaria	14 feb 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099800/000109980025000005/ew-20241231.htm
3	Edwards Lifesciences Reports Fourth Quarter Results (4T25)	Business Wire	Primaria	10 feb 2026	https://www.businesswire.com/news/home/20260210513744/en/Edwards-Lifesciences-Reports-Fourth-Quarter-Results/

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
4	EW's Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Up Y/Y (BPA ajustado 2025: 2,56 USD)	Zacks	Prensa	11 feb 2026	https://www.zacks.com/stock/news/2853826/ews-q4-earnings-miss-estimates-revenues-up-yy-stock-climbs
5	Form 8-K, anexo 99.1: resultados del 2T26	Edwards Lifesciences / SEC EDGAR	Primaria	23 jul 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001099800/000109980026000038/ex-991q22026.htm
6	Edwards Lifesciences Reports First Quarter Results (1T26)	Business Wire	Primaria	23 abr 2026	https://www.businesswire.com/news/home/20260423207342/en/Edwards-Lifesciences-Reports-First-Quarter-Results
7	EW Stock Up on Q4 Earnings and Revenue Beat (2024: ventas 5.440 M, BPA ajustado 2,43 USD)	Zacks	Prensa	12 feb 2025	https://www.zacks.com/stock/news/2414283/ew-stock-up-on-q4-earnings-and-revenue-beat-margins-crash
8	Informe anual 2025 (ARS): balance consolidado a 31-dic-2025	Edwards Lifesciences / SEC EDGAR	Primaria	26 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099800/000109980026000017/arwrap.htm
9	Informe anual 2024 (ARS): balance consolidado a 31-dic-2024 y 2023	Edwards Lifesciences / SEC EDGAR	Primaria	27 mar 2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099800/000109980025000016/a2024ar.htm
10	Edwards Lifesciences: resultado antes de impuestos, impuestos, flujo operativo y capex 2023-2025 (XBRL)	EDGAR Tools	Datos de mercado	oct 2026	https://app.edgar.tools/companies/EW
11	EW operating cash flow and capex history	Tickerleague	Datos de mercado	oct 2026	https://tickerleague.com/companies/EW/financials/operating-cash-flow
12	Edwards Lifesciences (EW) balance sheet (jun-2026)	Stock Analysis	Datos de mercado	oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ew/financials/balance-sheet/
13	EW financials: ventas, beneficio neto y BPA diluido 2021-2025	FN2	Datos de mercado	oct 2026	https://fn2.ai/earnings/ew/financials
14	Edwards Q2 2026: sales growth and guidance	MassDevice	Prensa	23 jul 2026	https://www.massdevice.com/edwards-q2-2026-sales-growth-guidance/
15	Edwards Lifesciences balance sheet (annual, Capital IQ)	Fintel	Datos de mercado	oct 2026	https://fintel.io/bs/us/ew
16	Edwards Comments on JenaValve Acquisition	Business Wire	Primaria	9 ene 2026	https://www.businesswire.com/news/home/20260109944511/en/Edwards-Comments-on-JenaValve-Acquisition
17	Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) Market report (cuota de Edwards de más del 55 % en 2025; cinco primeros ≈80 %)	Global Market Insights	Sectorial	2026	https://www.gminsights.com/industry-analysis/tavr-transcatheter-aortic-valve-replacement-market

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
18	TAVR market 2025: growth, innovation and competition	Life Science Market Research	Sectorial	2025	https://www.lifesciencemarketresearch.com/insights/tavr-market-2025-growth-innovation-and-competition
19	CMS Finalizes Updated TAVR National Coverage Determination	American College of Cardiology	Sectorial	15 sep 2026	https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2026/09/15/18/42/cms-finalizes-updated-tavr-national-coverage-determination
20	CMS expands TAVR Medicare coverage to asymptomatic patients	MedTech Dive	Prensa	sep 2026	https://www.medtechdive.com/news/cms-expands-tavr-medicare-coverage-to-asymptomatic-patients/830186/
21	Edwards Lifesciences Q2 earnings call highlights	MarketBeat	Prensa	23 jul 2026	https://www.marketbeat.com/instant-alerts/edwards-lifesciences-q2-earnings-call-highlights-2026-07-23/
22	Edwards Structural Heart Leadership Demonstrated Through Expanding Body of Scientific Evidence at New York Valves 2026	Edwards Lifesciences	Primaria	26 jun 2026	https://www.edwards.com/newsroom/news/2026-06-26-edwards--structural-heart-leadership-demonstrated-
23	FDA clears new indication for Edwards SAPIEN 3	Orange County Business Journal	Prensa	2026	https://www.ocbj.com/healthcare/fda-clears-new-indication-for-edwards-sapien-3/
24	Can Abbott Succeed Where Boston Sci Has Failed?	MDDI	Prensa	2025	https://www.mddionline.com/cardiovascular/can-abbott-succeed-where-boston-sci-has-failed-
25	Proxy statement 2026 (DEF 14A), portada y orden del día	Edwards Lifesciences / SEC EDGAR	Primaria	26 mar 2026	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1099800/000109980026000015/ew-20260326.htm
26	Edwards Lifesciences leadership directory	Komo	Prensa	2026	https://komo.ai/directory/edwards-lifesciences-leadership
27	Edwards says Mussallem to retire as chairman	Orange County Business Journal	Prensa	2024	https://www.ocbj.com/healthcare/edwards-says-mussallem-to-retire-as-chairman/
28	Edwards Lifesciences (NYSE:EW) VP Daniel Lippis Sells 619 Shares of Stock	MarketBeat	Prensa	8 oct 2026	https://www.marketbeat.com/instant-alerts/insider-edwards-lifesciences-nyse-ew-vp-daniel-lippis-sells-619-shares-of-stock-2026-10-08/
29	Is Edwards Lifesciences (NYSE:EW) Entering A Stronger Phase? (cotización del 13-oct-2026, calendario del 3T26)	Kalkine Media	Prensa	13 oct 2026	https://kalkinemedia.com/us/stocks/healthcare/is-edwards-lifesciences-nyseew-entering-a-stronger-phase

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
30	UBS reiterates Edwards Lifesciences stock rating on endpoint expectations	Investing.com	Analistas	oct 2026	https://www.investing.com/news/analyst-ratings/ubs-reiterates-edwards-lifesciences-stock-rating-on-endpoint-expectations-93CH-4939318
31	Edwards Lifesciences analyst ratings and price targets	Benzinga	Analistas	24 ago 2026	https://www.benzinga.com/quote/EW/sentiment
32	EW analysis: earnings and revenue estimates	Yahoo Finance	Datos de mercado	feb 2026	https://uk.finance.yahoo.com/quote/EW/analysis
33	Edwards Lifesciences 2Q26 TAVR sales top consensus ahead of key Medicare decision	MDDI	Prensa	24 jul 2026	https://www.mddionline.com/cardiovascular/edwards-lifesciences-2q26-tavr-sales-top-consensus-ahead-of-key-medicare-decision-clinical-trial
34	Edwards Lifesciences - 25 Year Stock Price History	Macrotrends	Datos de mercado	oct 2026	https://www.macrotrends.net/stocks/charts/EW/edwards-lifesciences/stock-price-history
35	Edwards Lifesciences (EW) price history, monthly	Digrin	Datos de mercado	oct 2026	https://www.digrin.com/stocks/detail/EW/price
36	Informe de Intuitive Surgical del repo (corte 6-oct-2026): comparables y transacciones con datos de MarketScreener, Stock Analysis y comunicados	Análisis propio (repo analisis-inversion)	Datos de mercado	6 oct 2026	https://www.marketscreener.com/quote/stock/EDWARDS-LIFESCIENCES-CORP-12521/finances/
37	Edwards Lifesciences Comments on FTC Action to Block Proposed Acquisition of JenaValve	Business Wire	Primaria	6 ago 2025	https://secure.businesswire.com/news/home/20250806182521/en/Edwards-Lifesciences-Comments-on-FTCs-Action-to-Block-Proposed-Acquisition-of-JenaValve
38	Edwards Lifesciences (EW) Stock Forecast (BPA no GAAP de S&P Global) y estadísticas, vía informe de Intuitive del 6-oct	Stock Analysis	Datos de mercado	6 oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/ew/forecast/
39	Edwards Lifesciences (EW): cotización y rango de 52 semanas	Stock Analysis	Datos de mercado	oct 2026	https://stockanalysis.com/stocks/EW/
40	Implied ERP by month (ERP T12m with sustainable payout), oct-2026: 4,20 %	Damodaran (NYU Stern)	Datos de mercado	oct 2026	https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xlsx
41	Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year (DGS10), 5,22 % (tomado del informe de Group 1 Automotive del repo, mismo corte)	FRED (Reserva Federal de San Luis)	Datos de mercado	13 oct 2026	https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
42	EW earnings history (BPA ajustado 2020-2022)	AlphaQuery / Zacks	Datos de mercado	oct 2026	https://www.alphaquery.com/stock/EW/earnings-history
43	Analyst Ratings for Edwards Lifesciences (EW)	StreetInsider	Analistas	oct 2026	https://www.streetinsider.com/rating_history.php?q=EW
44	Edwards Lifesciences Stock Forecast: Where Analysts See the Stock Going by 2027	TIKR	Analistas	2026	https://www.tikr.com/blog/edwards-lifesciences-stock-forecast-where-analysts-see-the-stock-going-by-2027

Ref.	Documento	Editor	Tipo	Fecha	Enlace
45	Edwards Lifesciences: early TAVR and EVOQUE launches will expand access (narrativa de la comunidad)	Simply Wall St	Foros y redes	sep 2026	https://www.simplywall.st/narratives/x2d7or7d-early-tavr-and-evoque-launches-will-expand-access-nur2
46	Did Broader TAVR Coverage Just Shift Edwards Lifesciences Stock Investment Narrative?	Webull	Foros y redes	sep 2026	https://www.webull.com/news/15573141563130880
47	Why Edwards Lifesciences (EW) Stock Is Down Today	Quiver Quant	Foros y redes	sep 2026	https://www.quiverquant.com/news/Why+Edwards+Lifesciences+(EW)+Stock+Is+Down+Today
48	Here's Why Edwards Lifesciences Stock Could Reach $150	TIKR	Foros y redes	ago 2026	https://www.tikr.com/blog/heres-why-edwards-lifesciences-stock-could-reach-150

Control de calidad del informe

Campos con dato: **80,6 %** · Secciones con menos del 60 % de campos cubiertos: **gobierno, bolsa** · Generado el 14 oct 2026.

Análisis hecho desde la nube con la red limitada a la búsqueda web: sec.gov, la web de la empresa y los proveedores de datos no se pudieron abrir, así que las cifras salen de extractos de búsqueda de los 10-K, de los comunicados 8-K y de agregadores (Stock Analysis, EDGAR Tools, Fintel), cruzadas cuando fue posible; la confianza es menor que en un análisis normal y lo que no cuadró está en null y en los huecos. Cuentas en USD con US GAAP; ejercicio natural. La cuenta es de operaciones continuadas (sin Critical Care, vendida en 2024) y solo cubre 2023-2025: los años anteriores mezclan perímetros. Las amortizaciones son estimación propia (≈2,6 % de las ventas). El precio (85,76 USD) es el cierre del 13-oct-2026 citado por la prensa [29]. Comparables y transacciones reutilizados del informe de Intuitive del repo (6-oct-2026) [36]. El BPA del objetivo a 12 meses es el nuestro, cercano al ajustado de la empresa (≈3 % por debajo porque contamos parte de los cargos recurrentes); el PER histórico usa el BPA ajustado publicado.

Este documento es un análisis elaborado de forma automatizada a partir de fuentes públicas. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de compra o venta. Las cifras marcadas como estimación y los escenarios son hipótesis de trabajo y deben verificarse antes de tomar cualquier decisión.